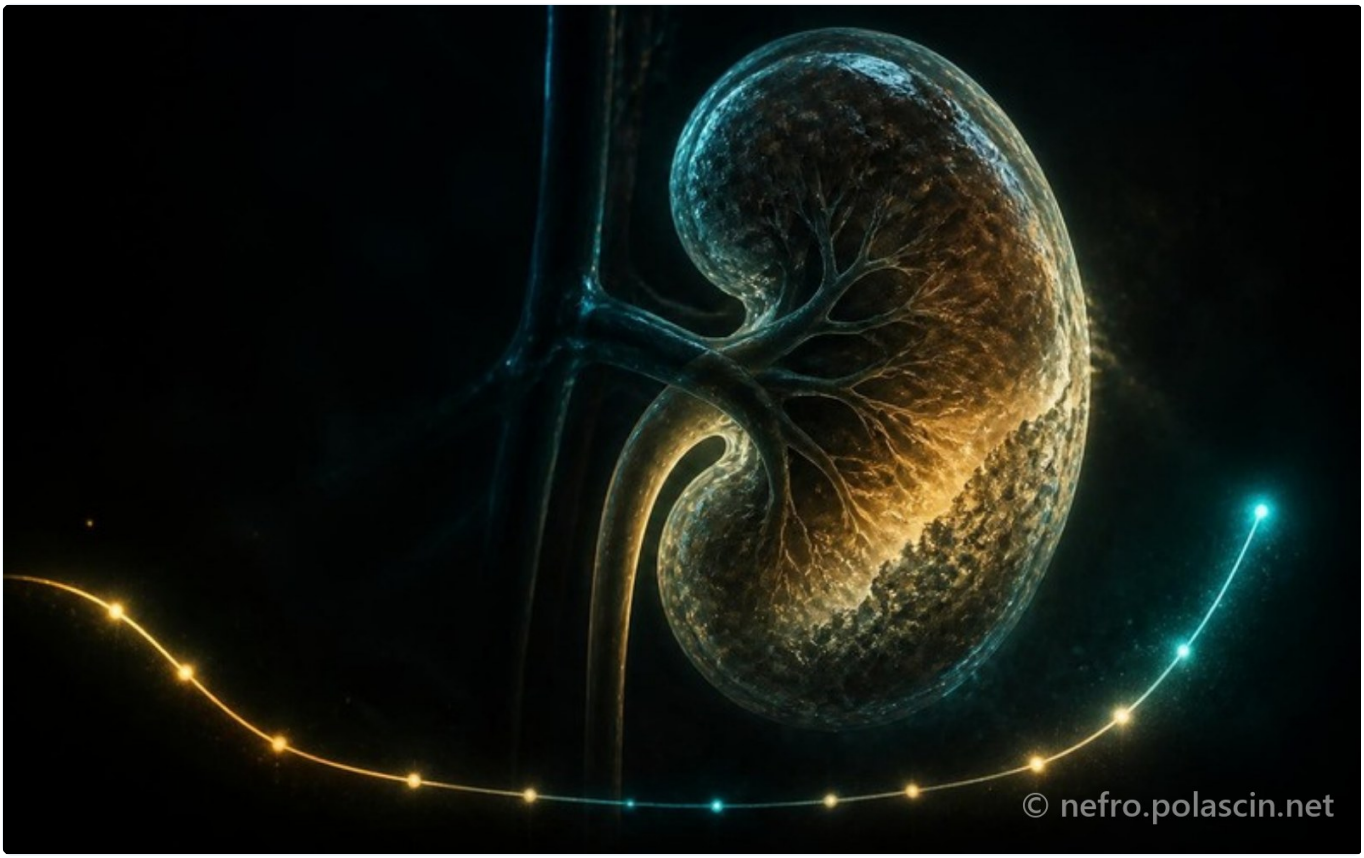
Od spomaľovania progresie k remisii: tichá revolúcia v nefrológii

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 17.05.2026



Ilustračná scéna. Doterajším cieľom bolo spomaliť pokles — dnes sa objavuje možnosť časť funkcie získať späť.

Chronická choroba obličiek už dávno nie je iba „nefrologická diagnóza“. V skutočnosti je často konečným prejavom širšieho metabolického, kardiovaskulárneho a endokrinného narušenia organizmu. Diabetes mellitus, obezita, hypertenzia, srdcové zlyhávanie, vaskulárna dysfunkcia a zápal nevystupujú izolovane. V pacientovi vytvárajú jeden prepojený chorobný príbeh.

Práve preto sa v modernej medicíne čoraz viac hovorí o kardio-renálno-metabolickom syndróme. Tento pojem lepšie vystihuje realitu polymorbídneho pacienta než tradičné delenie na samostatné špecializácie. Pacient s chronickou chorobou obličiek nie je len pacientom s poklesom glomerulovej filtrácie. Je často pacientom s diabetom, rezistentnou hypertenziou, aterosklerózou, srdcovým zlyhávaním, obezitou, polyfarmáciou a sociálnymi bariérami, ktoré zásadne ovplyvňujú výsledok liečby.

Nový model starostlivosti

Americká organizácia Monogram Health začínala so zameraním na obličkové ochorenia. Postupne však rozšírila svoj prístup, pretože u pacientov s chronickou chorobou obličiek nemožno účinne liečiť iba samotné obličky. Potrebná je koordinovaná, multidisciplinárna a prakticky orientovaná starostlivosť.

Zaujímavým prvkom tohto modelu je poskytovanie zdravotnej starostlivosti priamo v domácom prostredí pacienta. Domácnosť často prezradí viac než ambulantná kontrola. Lekár alebo zdravotnícky tím vidí, ako pacient skutočne žije, aké lieky má doma, ako ich užíva, aké má stravovacie návyky, aké má sociálne zázemie a aké prekážky mu bránia v dodržiavaní odporúčaní.

Takýto pohľad je v nefrológii mimoriadne cenný. Chronická choroba obličiek nie je len laboratórna hodnota kreatinínu, eGFR alebo albuminúrie. Je to dlhodobý stav, ktorý sa odohráva v každodennom živote pacienta.

Algoritmy ako opora, nie náhrada lekára

Monogram Health využíva algoritmy založené na dôkazoch, ktoré pomáhajú klinikom systematicky vyhodnocovať stav pacienta. Nejde o nahradenie lekára, ale o zlepšenie rozhodovania. Dobrý algoritmus núti tím položiť správne otázky v správnom poradí.

Príkladom je prístup k rezistentnej hypertenzii. Skôr než sa pacient označí za skutočne rezistentného, treba preveriť viacero faktorov: správnosť merania krvného tlaku, adherenciu k liečbe, dostupnosť liekov, príjem sodíka, liekové interakcie a sekundárne príčiny hypertenzie.

V jednom z opisovaných prípadov viedol takýto systematický postup k odhaleniu hyperaldosteronizmu. Pacient, ktorý bol predtým vnímaný najmä ako ťažko kontrolovateľný hypertonik, získal presnejšiu diagnózu a cielenejšiu liečbu. Toto je presne priestor, kde môže dobrá medicína zmeniť trajektóriu choroby.

Výsledky, ktoré stoja za pozornosť

Podľa uvádzaných údajov dosiahol program Monogram Health významné zlepšenia v klinických výsledkoch. Spomína sa 35 % pokles hospitalizácií a 44 % pokles rehospitalizácií. Rovnako dôležitý je kvalitnejší prechod pacientov do dialyzačnej liečby.

V praxi to znamená menej urgentných začiatkov dialýzy cez centrálny venózny katéter, viac plánovaných štartov, viac permanentných cievnych prístupov a vyšší podiel pacientov, ktorí môžu začať domácu dialýzu. Pre nefrológa je toto zásadný rozdiel. Pacient, ktorý začína dialýzu plánovane a stabilizovane, má úplne inú prognózu než pacient, ktorý prichádza v urémii cez urgentný príjem.

Štyri piliere diabetickej choroby obličiek

Najväčšia zmena posledných rokov spočíva v tom, že už nehovoríme iba o spomaľovaní progresie. Pri vhodne zvolenej kombinovanej liečbe sa začína hovoriť o stabilizácii, výraznom znížení rizika a u časti pacientov dokonca o možnosti funkčnej remisie.

Pri diabetickej chorobe obličiek sa čoraz viac uplatňuje kombinácia viacerých liekových skupín:

- inhibítory SGLT2,
- agonisty receptora GLP-1,
- ACE inhibítory alebo blokátory receptorov AT1 pre angiotenzín II,
- nesteroidné antagonisty mineralokortikoidového receptora, napríklad finerenón.

Tieto lieky nepôsobia iba na jednu hodnotu v laboratórnom výsledku. Zasahujú do hemodynamiky glomerulu, zápalu, fibrózy, metabolizmu, krvného tlaku, albuminúrie a kardiovaskulárneho rizika. Práve kombinácia týchto účinkov mení spôsob, akým dnes uvažujeme o nefroprotekcii.

Od defenzívnej nefrológie k aktívnej zmene prognózy

Dlhé roky bola nefrológia vnímaná najmä ako odbor, ktorý sa snaží oddialiť nevyhnutné. Spomaliť pokles eGFR. Pripraviť pacienta na dialýzu. Zvládnuť komplikácie pokročilej chronickej choroby obličiek.

Dnes sa tento pohľad mení. Moderná nefrológia má k dispozícii nástroje, ktoré môžu zásadne zmeniť prirodzený priebeh ochorenia. Nestačí však predpísať jeden liek. Potrebná je včasná identifikácia rizikového pacienta, dôsledné využitie dát, multidisciplinárna spolupráca, kontrola adherencie a schopnosť preniesť medicínu z ambulancie do reálneho života pacienta.

Tu je však potrebné byť triezvy. Slovo „remisia“ pri chronickej chorobe obličiek treba používať opatrne. Nie každý pacient dosiahne zlepšenie funkcie obličiek. Nie každá stabilizácia znamená skutočné zvrátenie choroby. Ale pri správne vybraných pacientoch, najmä v skorších štádiách ochorenia, už dnes máme dôvod hovoriť o oveľa ambicióznejších cieľoch než kedysi.

Záver

Tichá revolúcia v nefrológii nespočíva v jednom zázračnom lieku. Spočíva v zmene myslenia. Chronickú chorobu obličiek musíme chápať ako súčasť komplexného kardio-renálno-metabolického ochorenia. Pacienta musíme vidieť nielen cez laboratórne parametre, ale aj cez jeho domáce prostredie, liekovú realitu, sociálne možnosti a celkové riziko.

Ak sa podarí spojiť modernú farmakoterapiu, presné algoritmy, domácu starostlivosť a multidisciplinárny tím,

nefrológia sa môže posunúť od pasívneho čakania na zlyhanie obličiek k aktívnemu ovplyvňovaniu osudu pacienta.

A to je zmena, ktorú nemožno prehliadnuť.

Zdroj:

Becker's Hospital Review: From Slowing Progression to Remission: The Quiet Nephrology Revolution

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=od-spomalovania-progresie-k-remisii-ticha-revolucia-v-nefrologii · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.